EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88306
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-10 11:30:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: UBERLINDA DE LAS ROS CONCHA VASQUEZ			**RUN**	: 8.066.240-8
F.Nac	: 20-01-1959	**Edad**	: 65 AÑOS, 5 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: LA NUEVA VIDA PASAJE LA LUNA 676			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 992639690		
Fecha Ingreso	: 2024-07-06	**Fecha Egreso**	: 2024-07-10 11:30:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Neumonias bilateales a repetición
2. ACV isquémicos secuelares (ACA izquierda/ tálamo-capsular derecho) + probable encefalopatía hipóxico isquémica (última hospitalización)
3. ITU reciente
4. DM2 IR mal control metabólico
5. HTA
6. UPP sacra

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18-NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 65 años postrada Deterioro Neurocognitivo probable origen vascular. con antecedente mórbidos ACV, DM, EPOC, TEP en TACO, multiples hospitalizaciones por cuadros respiratorios. Usuaria S. Foley y SNG. Usuaria de O2 domiciliario asociado a terapia aspirativa domiciliaria dirigida por familiares (capacitados para ello)
Acude por exacerbación de síntomas basales: mayor disnea, aumento en frecuencia e intensidad de accesos de tos humeda con expectoración inefectiva.
Se intenta en servicio de urgencias apoyo con KNT para eventual retorno a domicilio, sin éxito.
Exámenes de laboratorio:
Glicemia 236 Creatinina 0.7 BT 0.9 GOT 42 GPT 18 PCR 266 Uremia 35 BUN 16 ELP 129/5.7/91 Hb 9 Leucocitos 37900 Plaquetas 642000 INR 1.54. Se toma TAC DE TORAX
Focos de neumonía en ambos campos pulmonares con mayor compromiso bibasal asociado a opacidades en vidrio esmerilado. Cardiomegalia.
TAC DE CEREBRO Infarto subagudo tardío-crónico en territorio de arteria cerebral anterior izquierda. Infarto lacunares antiguos en cuerpos estriados y tálamo derecho. Focos de hipodensidad de la sustancia blanca, de probable carácter microangiopatico.
Signos de disminución de volumen difuso del parénquima encefálico.
En vista de condiciones, se decide ingreso a servicio

Evaluada por Neurologo Paciente en malas condiciones generales, hemodinamia estable, hoy afebril, bajos requerimientos O2 adicional por naricera, sin disnea reposo, control metabólico irregular. Se realiza anamnesis con hija cuidadora El día que consulta presenta taquipnea, protruye lengua, emite balbuceo repetitivo y movimientos involuntarios en ESD (M0 basal) de casi 30 minutos de duración ¿?. Hija muestra video del evento que sugiere convulsión secundaria a ACV secuelados + infección aguda.
Estado basal neurológico y neurológico actual-> vigilia fluctuante, no comprende órdenes, no emite lenguaje

espontáneo, solo sonidos, M2 Braquial izq/M0 ESD y EEII, espasticidad en 4 extremidades, plantares extesores, sin respuesta motora al dolor (adquiere vigilia), resto no evaluable. Se revisan TC cerebro (desde febrero hasta la fecha): impresiona con severo daño no solo microangiopático, hipodensidad simétrica de ganglios basales bilaterales que puede ser 2rio a encefalopatía hipóxico isquémica, no impresiona con nuevo acv isquémico, más lesiones ya descritas. Plan -> Agrego fenitoína 150 mg c/12 hrs SNG - > Mantengo Levetiracetam 1 gr sng c/12 hrs (no aumentar por posible somnolencia asociada) -> re-evaluar por neurología SOS/ IPD descarte ACV isquémico agudo.
Cultivos Positivo Aislamiento: Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecium, : Enterococcus resistente a vancomicina.
Exámenes control: Hemoglobina : 8,3 * g/dl Hematocrito : 26,7 * o/o Recuento de leucocitos : 18,10 * mil/ul Recuento Hematies : 3,33 Mill/ul Plaquetas : 653 Segmentados : 70 o/o Linfocitos : 17 o/o Monocitos : 10 Procalcitonina : 0,28 pH : 7,47 pCO2 : 40,3 mmHg
pO2 : 60,0 * mmHg HCO3 ACT. : 29,9 Proteina C Reactiva : 177,1
en su 6 dia de antibiótico con mejoría de la clínica sin requerimiento oxígeno, afebril, normocardica, normotensa em condiciones de continuar con hospitalización Domiciliaria

PLAN DE MANEJO:

HODOM
TTO ATB POR 4 DIAS
re-evaluar por neurología SOS
CONTROL POLI DE POSTRADO

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo
2. Curación Por Enfermería De Upp
3. Insulina Nph 24 U Am Y 20 U Pm Sc
4. Aspiración De Secreciones Sos
5. Ceftriaxona Frasco 1 Gramo 2 Frasco Cada 24 Hrs. Por 4 Dias Via Endovenosa
6. Atorvastatina Comprimido 40 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Sng
7. Bisoprolol Comprimido 2,5 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Sng
8. Famotidina Comprimido 40 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Sng
9. Levetiracetam Comprimido 500 Milígramos 2 Comprimido Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Sng
10. Quetiapina Comprimido 25 Miligramos 1 Comprimido Cada 24 Hrs. Por 30 Dias Via Sng
11. Fenitoina Comprimido 100 Miligramos 1 Comprimido Y 0.5 Cada 12 Hrs. Por 30 Dias Via Sng
12. Ipratropio Inhalador Frasco Unidad 2 Puff C 6h
13. Exámenes control en 48 horas por HODOM

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO